



# HOSPITAL SERIAN

**TITLE: POLISI JABATAN FARMASI**

**DOCUMENT IDENTIFICATION: HS / P&P/18 (PHARM)**

**UNIT/DEPARTMENT/DIVISION: PHARMACY**

**EFFECTIVE DATE:**

**15 SEPTEMBER 2026**

**NEXT REVIEW DATE:**

**15 SEPTEMBER 2029**

**VERSION:**

**4.0**

**REVISION:**

**1.0**

| Prepared by:                                                                        | Checked by:                                                                         | Approved by:                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Name: Mahani Ahmat<br>Designation: Head of Pharmacy                                 | Name: Mahani Ahmat<br>Designation: Head of Pharmacy                                 | Name: Dr Maria Binti Mesran<br>Designation: Hospital Director                         |



|                            |                            |         |     |          |     |
|----------------------------|----------------------------|---------|-----|----------|-----|
| DOCUMENT TITLE             | OPERATIONAL POLICY<br>&SOP | VERSION | 3.0 | REVISION | 2.0 |
| DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)          | Page    |     |          |     |

**AMENDMENT PAGE**

| Date of Amendment | Issues No / Amendment No. | Details of Amendment | Signature of Person who initiated the change | Signature of person who approved the change |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                   |                           |                      |                                              |                                             |
|                   |                           |                      |                                              |                                             |
|                   |                           |                      |                                              |                                             |
|                   |                           |                      |                                              |                                             |
|                   |                           |                      |                                              |                                             |
|                   |                           |                      |                                              |                                             |

**CONTROLLED DOCUMENT LIST**

| Controlled Copy No. | Recipient                          |
|---------------------|------------------------------------|
| 1                   | Hospital Director, Hospital Serian |
| 2                   | Unit Pharmacy, Hospital Serian     |
| 3                   | Quality Unit, Hospital Serian      |

Hospital Serian

All rights reserved. For intended and authorized use by Hospital Serian only. No part of this document may be used, reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior written permission from the Quality Unit of Hospital Serian

To ensure you have the current copy of the document, always refer to the CONTROLLED COPY online.

|                                                                                   |                         |                                   |             |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
|  | <b>HOSPITAL SERIAN</b>  |                                   |             |            |          |            |
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | <b>POLISI OPERASI<br/>FARMASI</b> | VERSION     | <b>4.0</b> | REVISION | <b>0.0</b> |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION | <b>P&amp;P/18 (PHARMACY)</b>      | <b>Page</b> |            |          |            |

---

## **HOSPITAL SERIAN**

### **POLISI OPERASI JABATAN FARMASI**

#### **1. VISI, MISI DAN OBJEKTIF**

##### **1.1 Visi**

Memberi perkhidmatan farmasi yang terbaik demi kesihatan dan kesejahteraan negara.

##### **1.2 Misi**

Menyediakan perkhidmatan farmasi yang selamat, berkualiti dan efektif dengan mengutamakan pelanggan.

##### **1.3 Objektif**

- i. Menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif kepada pesakit dan unit-unit lain di dalam hospital.
- ii. Memastikan pesakit dibekalkan dengan ubat-ubatan yang berkualiti dengan indikasi dan kuantiti yang betul.
- iii. Memastikan semua ubat yang dibekalkan kepada pesakit dibungkus, dilabel dan dispens dengan arahan dan informasi yang betul.
- iv. Memastikan stok ubat-ubatan dan peralatan perubatan sentiasa mencukupi untuk kegunaan hospital.

#### **2. ORGANISASI**

##### **2.1 Struktur organisasi**

2.1.1 Unit Farmasi diketuai oleh Ketua Jabatan Farmasi (KJF) dan diuruskan melalui tiga subunit iaitu Farmasi Pesakit Dalam, Farmasi Pesakit Luar dan Farmasi Logistik.

2.1.2 KJF adalah bertanggungjawab ke atas pentadbiran semua subunit di Jabatan Farmasi.

|  | HOSPITAL SERIAN         |                        |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)      | Page    |     |          |     |

2.1.3 KJF bertanggungjawab terhadap Polisi Operasi Unit Farmasi, pengurusan organisasi dan sumber manusia, pelan tindakan bagi peruntukan kewangan, pemerhatian ke atas semua perkhidmatan yang ditawarkan dan penyediaan laporan-laporan yang berkaitan dengan perkhidmatan keseluruhan Unit Farmasi.

### 3. LOKASI JABATAN FARMASI

3.1 Farmasi Pesakit Luar terletak di hujung blok Jabatan Pesakit Luar, manakala Farmasi Pesakit Dalam dan Farmasi Logistik terletak di bahagian belakang, bersebelahan dengan Wad Bersalin.

### 4. WAKTU OPERASI

4.1 Waktu operasi biasa semasa waktu pejabat adalah:

| Unit                  | Hari Bekerja                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Farmasi Pesakit Dalam | 8:00 pagi – 5:00 petang                                    |
| Farmasi Pesakit Luar  | 7:30 pagi – 5:00 petang (atau sehingga preskripsi selesai) |
| Farmasi Logistik      | 8:00 pagi – 5:00 petang                                    |

4.2 Waktu operasi lanjutan semasa waktu luar pejabat adalah:

| Unit                  | Jenis syif                          | Masa                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Farmasi Pesakit Dalam | Kerja lebih masa                    | Sabtu, Ahad & Kelepasan am: 9:00 pagi – 2:00 petang         |
|                       | Tugas lebih masa ( <i>On-call</i> ) | Setiap hari: Selepas waktu operasi biasa & kerja lebih masa |
| Farmasi Pesakit Luar  | Kerja lebih masa                    | Sabtu, Ahad & Kelepasan am: 8:00 pagi – 2:00 petang         |

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

|                  |                                        |                                                                |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Tugas lebih<br>masa ( <i>On-call</i> ) | Setiap hari: Selepas waktu operasi<br>biasa & kerja lebih masa |
| Farmasi Logistik | -                                      | Tutup                                                          |

4.3 Pendispensan ubat susulan (slip IOU) di Farmasi Pesakit Luar hanya dilayan sehingga jam 4.30 petang pada hari bekerja.

4.4 Perkhidmatan tugas atas panggilan disediakan selepas waktu pejabat, dikendalikan oleh seorang Penolong Pegawai Farmasi dan seorang Pegawai Farmasi.

4.5 Penolong Pegawai Farmasi akan dipanggil untuk bekalan ubat ke wad bagi pesakit baru masuk wad.

4.6 Pegawai Farmasi akan dipanggil untuk penyediaan maklumat ubat dan pembekalan ubat psikotropik.

4.7 Permohonan/ pembekalan ubat daripada staf farmasi atas panggilan selepas waktu pejabat hanya dibenarkan untuk ubat yang tiada dalam senarai stok wad.

4.8 Jadual tugas tengah hari (*lunch duties*) hendaklah disediakan di Farmasi Pesakit Luar untuk menjamin kesinambungan pendispensan dan pembekalan ubat.

## 5. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

### 5.1 Pengurusan Sumber Manusia

5.1.1 Unit Farmasi diketuai oleh Ketua Jabatan Farmasi yang dilantik oleh Bahagian sumber manusia Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan Negeri.

5.1.2 Setiap unit iaitu Farmasi Pesakit Dalam, Farmasi Pesakit Luar dan Farmasi Logistik diketuai oleh Pegawai Farmasi yang dilantik oleh Ketua Jabatan Farmasi.

5.1.3 Semua pegawai farmasi wajib mempunyai pendaftaran sah dengan Lembaga Farmasi Malaysia dan memiliki Sijil Perakuan Tahunan (*Annual Retention Certificate*).

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

5.1.4 Penempatan staf (*Deployment*) dilakukan secara *ad-hoc* sekiranya terdapat kekurangan tenaga kerja di bahagian atau unit tertentu.

5.1.5 Setiap staf baru yang melapor diri di Unit Farmasi harus diberi taklimat secara umum oleh KJF dan sesi orientasi berdasarkan senarai semak setiap unit akan diberikan oleh Ketua Unit semasa penempatan latihan mengikut jadual yang telah disediakan.

5.1.6 Senarai semak orientasi yang dilengkapi hendaklah disimpan dalam fail.

5.1.7 Setiap staf harus merujuk kepada manual prosedur kerja dan myPortfolio masing-masing supaya memahami bidang tugas sendiri dan menjalankan tugas mengikut prosedur kerja yang ditetapkan.

5.1.8 Analisis keperluan staf atau jawatan baru hendaklah dilakukan oleh KJF dengan membuat analisis berdasarkan norma kerja farmasi.

5.1.9 Permohonan pengisian jawatan kosong dan penempatan tambahan boleh dikemukakan kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi JKN Sarawak berserta dengan laporan analisis berdasarkan norma kerja farmasi sebagai justifikasi.

## 5.2 Penilaian Prestasi Tahunan

5.2.1 Setiap staf dikehendaki menyediakan Sasaran Kerja Utama (SKU) dalam myPerformance, Sistem HRMIS pada awal setiap tahun kepada Pegawai Penilai Pertama (PPP).

5.2.2 Penilaian prestasi Pegawai Yang Dinilai (PYD) oleh Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Kedua (PPK) hendaklah dilaksanakan secara objektif, adil dan telus mengikut pekeliling perkhidmatan serta surat pekeliling perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa

5.2.3 Penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar PYD seperti yang disasarkan dalam senarai tugas dalam tahun yang dinilai.

5.2.4 Penilaian tidak dibuat tergesa-gesa atau di saat akhir.

5.2.5 Penilaian tidak dipengaruhi oleh prestasi tahun sebelumnya.

5.2.6 PPP dan PPK tidak memberi perhatian lebih bagi perkara yang

|  | HOSPITAL SERIAN                |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

baru berlaku sama ada positif atau negatif yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan pegawai di sepanjang tahun.

### 5.3 Penjadualan Tugas syif

5.3.1 Penjadualan tugas syif disediakan secara bulanan oleh Pegawai Farmasi DIS (untuk Pegawai Farmasi), manakala Penolong Pegawai Farmasi U6 (untuk Penolong Pegawai Farmasi) bagi tugas berikut :

- i. Kerja lebih masa hujung minggu / Cuti Umum
- ii. Kerja atas panggilan
- iii. Kerja lebih masa awal pagi (7.30 – 8.00pagi)
- iv. Tugas selepas jam 5.00petang (jika pesakit masih ada di Farmasi pesakit luar)
- v. Tugas waktu rehat tengah hari :
  - Seorang Pegawai Farmasi yang dijadualkan kerja atas panggilan akan bertugas (Isnin – Khamis), kecuali pada hari jumaat 2 orang Pegawai Farmasi yang bertugas iaitu seorang pada jam 11.45pagi – 1.15tengah hari, seorang lagi pada jam 11.45pagi – 2.15petang.
  - 3 Penolong Pegawai Farmasi yang dijadualkan kerja atas panggilan akan bertugas(Isnin – Khamis),kecuali pada hari jumaat 3 orang yang dijadualkan kerja atas panggilan mengikut kumpulan secara bergiliran setiap 1 jam/ seorang pegawai yang bertugas.
  - Pada hari Isnin – Khamis pegawai yang bertugas waktu rehat tengah hari dibenarkan berehat pada jam 12.00 tengah hari – 1.00 tengah hari.
- vi. Tugas tambahan yang memerlukan perkhidmatan / kerja yang perlu diuruskan terutama pada cuti umum yang di luar jangka.

5.3.2 Setiap Pegawai Farmasi yang menjalankan tugas lebih masa dibenarkan menuntut cuti gantian, manakala Penolong Pegawai Farmasi dibenarkan menuntut cuti gantian atau elaun lebih masa (ELM), rujukan Perintah Am Bab G.

5.3.3 Tuntutan kerja lebih masa mesti dihantar ke pejabat pentadbiran selewat-lewatnya pada 5hb bulan berikutnya atau mengikut jadual yang akan

|  | HOSPITAL SERIAN                |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

disediakan oleh unit kewangan. Sebarang rayuan mengenai kelewatan penghantaran borang tidak akan dipertimbangkan kecuali mempunyai alasan yang munasabah dan mendapat kelulusan daripada Pengarah sebelum tuntutan dikemukakan kepada unit kewangan.

5.3.4. Dokumen tuntutan kerja lebih masa termasuk Arahan beri tugas Lebih Masa, Penyata Kerja Lebih Masa, Keterangan Tuntutan Kerja Lebih Masa, Jadual Pergerakan Kerja Lebih Masa, Jadual Tugas, salinan Kad Perakam Waktu, salinan slip gaji dan salinan akaun bank.

#### 5.4 Pengurusan Cuti Rehat dan Cuti Sakit

5.4.1 Semua staf harus memohon cuti rehat melalui sistem HRMIS sebelum tarikh cuti bermula. Penyokong dan pelulus cuti rehat adalah mengikut penetapan jadual yang telah disediakan.

5.4.2 Staf yang ingin memohon cuti rehat harus mengambil kira bilangan anggota yang masih bekerja sewaktu cuti rehat beliau supaya unit bertugas beliau tidak mengalami masalah kekurangan tenaga kerja.

5.4.3 Bagi permohonan cuti sakit mengisi borang dengan melampirkan sijil sakit yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau Swasta. Penyokong adalah KJF dan pelulus cuti rehat adalah Pengarah Hospital.

#### 5.5 Pengurusan Cuti Gantian

5.5.1 Cuti Gantian (*Equivalent Time-Off*, ETO) yang dikumpul perlu dituntut dalam masa 6 bulan.

5.5.2 Minimum cuti gantian dikumpul adalah 15 minit dan dikumpul dalam gandaan 15 minit. Pengumpulan ETO mesti direkodkan dalam buku rekod ETO oleh masing-masing.

5.5.3 Bagi permohonan cuti gantian, setiap permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang permohonan cuti gantian serta kemaskini rekod buku ETO masing-masing. Minimum permohonan cuti gantian adalah 15 minit.

5.5.4 Penyokong dan pelulus cuti gantian adalah mengikut ketetapan penyokong dan pelulus cuti rehat.



|  | HOSPITAL SERIAN |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE  | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
| DOCUMENT IDENTIFICATION                                                           | Page            |                                                |         |     |          |     |

## 5.6 Pengurusan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Pejabat

5.6.1 Hanya pegawai yang tidak mengumpul atau tiada baki cuti gantian (ETO) adalah layak untuk memohon kebenaran ini. Pegawai yang mempunyai baki cuti gantian hendaklah menggunakan cuti gantian terlebih dahulu.

5.6.2 Permohonan hendaklah dibuat kepada KJF dan pegawai pemohon perlu memaklumkan kepada ketua unit masing-masing. Borang permohonan kebenaran meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja mesti diisi dan diluluskan oleh KJF terlebih dahulu.

5.6.3 Tempoh maksimum kebenaran diberikan adalah 4 jam (termasuk waktu rehat).

5.6.4 KJF berhak untuk mengarahkan pegawai yang berkenaan untuk menggantikan semula tempoh waktu bekerja yang telah digunakan untuk menyiapkan kerja yang belum diselesaikan.

5.6.5 Kebenaran ini adalah diberikan atas budi bicara KJF setelah mengambil kira kepentingan perkhidmatan dan terhad kepada urusan peribadi yang hanya boleh atau terpaksa dilakukan dalam waktu pejabat.

5.6.6 Pegawai yang mempunyai tugas rasmi luar pejabat dikehendaki mengisi borang permohonan untuk tugas rasmi luar pejabat. Pegawai penyokong adalah Ketua unit dan pelulus adalah Pengarah Hospital.

## 5.7 Tuntutan Perjalanan Rasmi

5.7.1 Semua tuntutan perjalanan mestilah disertakan dokumen-dokumen sokongan termasuk Salinan Tiket Kapal Terbang, Boarding Pass, Surat Arahan Bertugas, Surat Panggilan, resit Hotel/ Teksi dan lain-lain.

5.7.2 Kesemua tuntutan perjalanan rasmi dibuat dengan menggunakan Modul Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri dalam Sistem HRMIS dan dicetak keluar.

5.7.3 Borang tuntutan mesti dihantar selewat-lewatnya pada atau sebelum 5hb bulan berikutnya atau mengikut jadual yang akan disediakan oleh unit kewangan. Sebarang rayuan mengenai kelewatan penghantaran borang tidak akan dipertimbangkan kecuali mempunyai alasan yang munasabah dan mendapat kelulusan daripada Pengarah sebelum tuntutan dikemukakan kepada unit kewangan.

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

## 5.8 Pengurusan Aset Alih Kerajaan

5.8.1 Pengurusan aset alih hendaklah mengikut tatacara perbendaharaan terkini (1Pekeliling Perbendaraan).

5.8.2 Semua aset alih kerajaan mesti didaftarkan dalam Daftar Harta Modal (KEW.PA-3) atau Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-4)

5.8.3 Pegawai Aset bertanggungjawab menyediakan dan mengemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) dan Senarai Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-6) di Unit Farmasi.

5.8.4 Senarai Aset Alih yang ditempatkan di lokasi hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset dengan menggunakan KEW.PA-7.

5.8.5 Setiap aset baru harus diperolehi melalui prosedur perolehan kerajaan.

5.8.6 Setiap harta modal mesti diuji dan ditauliahkan oleh Perkhidmatan Sokongan Hospital dengan kehadiran pembekal sebelum didaftarkan dan digunakan (jika berkenaan).

## 5.9 Pengurusan Kualiti

5.9.1 KJF bertanggungjawab terhadap pengurusan kualiti Unit Farmasi dan dibantu oleh ketua subunit masing-masing.

5.9.2 Kajian Kepuasan Pelanggan dan Kajian Piagam Pelanggan perlu dijalankan 2 kali setahun oleh semua subunit untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan farmasi.

5.9.3 Analisa terhadap Kajian Kepuasan Pelanggan dan Kajian Piagam Pelanggan perlu dijalankan dan tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan terhadap piagam yang tidak tercapai.

## 5.10 Latihan Dalam Perkhidmatan

5.10.1 KJF bertanggungjawab merancang latihan untuk semua staf.

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

5.10.2 KJF harus memastikan semua Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi telah berdaftar dalam sistem myCPD dan menggunakan log book myCPD.

5.10.3 Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi harus mencapai sekurang-kurangnya 40 mata kredit CPD setahun.

5.10.4 Anggota farmasi bagi kategori Sokongan untuk mencapai 40 jam latihan dan dikunci masuk dalam HRMIS.

## 6. **SKOP PERKHIDMATAN FARMASI DAN POLISI OPERASI**

### 6.1 UNIT FARMASI LOGISTIK

#### 6.1.1 Perolehan atau pesanan stok

6.1.1.1 Perolehan stok dibuat melalui 3 cara iaitu:

- Perolehan sendiri melalui sistem PhIS dan eperolehan untuk item Approved Products Purchase List (APPL) daripada syarikat konsesi Pharmaniaga Sdn. Bhd.
- Perolehan sendiri melalui sistem eperolehan untuk item Kontrak Pusat KKM, item Kontrak Negeri (gas perubatan dari syarikat Linde EOX).
- Pesanan ke Cawangan Farmasi Logistik Negeri Sarawak (CFLN) untuk item Local Purchase tertakluk kepada senarai item dalam katalog CFLN. Pesanan dibuat 3 bulan sekali (pesanan penggal) atau bila perlu (pesanan tambahan)

6.1.1.2 Pesanan kerajaan dikeluarkan sendiri oleh Unit Farmasi Logistik agar proses perolehan berjalan lancar iaitu dalam masa 3 hari bekerja dari pengeluaran nota minta dengan syarat tiada gangguan sistem atau masalah lain.

6.1.1.3 Padanan bayaran akan dibuat oleh Unit Farmasi Logistik dan pembayaran akan dilakukan oleh Unit Kewangan Hospital Sentosa.

6.1.1.4 Pesanan Kerajaan dengan dokumen bayaran yang lengkap akan dihantar ke Unit Kewangan dalam masa 3 hari dari tarikh padanan bayaran dibuat dengan syarat tiada masalah dokumen bayaran.

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

6.1.1.5 Pegawai yang terlibat dalam urusan perolehan perlu mempunyai surat kuasa sebagai peminta dan pelulus yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan.

## 6.1.2 Penerimaan

6.1.2.1 Ketua Jabatan perlu melantik Pegawai Penerima yang bertanggungjawab untuk menerima dan memeriksa stok yang diterima.

6.1.2.2 Proses penerimaan dilaksanakan bagi:

- memastikan stok yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.
- menentukan kuantiti dan kualiti stok yang diterima.
- memastikan stok yang diterima berada dalam keadaan baik, sempurna, dan selamat untuk digunakan.

6.1.2.3 Stok yang diterima mesti disemak bersama dokumen-dokumen seperti

- Pesanan Rasmi Kerajaan
- Nota atau bil serahan
- Invois
- Dokumen-dokumen lain yang berkenaan

6.1.2.4 Stok yang diterima mesti bertarikh luput tidak kurang daripada 2/3 jangka hayat. Jika kurang perlu memohon LOU dari pembekal.

6.1.2.5 Stok yang diterima perlu 'dikira, diukur, ditimbang atau diuji' serta merta oleh Pegawai Penerima. Sekiranya pengesahan penerimaan tidak dapat dilakukan dengan serta-merta, dokumen penerimaan tersebut perlu dicop 'Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji'.

6.1.2.6 Penerimaan perlu direkodkan dalam sistem PhIS dan dicatatkan dalam Kad Daftar Stok Kew.PS-3.

## 6.1.3 Penyimpanan

6.1.3.1. Ruang stor hendaklah digunakan sepenuhnya dengan mengambil kira faktor keselamatan, kemudahan pengeluaran, verifikasi dan kekemasan stor. Stor juga perlu mempunyai susun atur yang sistematik dan praktik untuk membolehkan aktiviti pengurusan stor berjalan dengan lancar, selamat, mudah dan menjimatkan masa.

|  | HOSPITAL SERIAN                |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

6.1.3.2 Penyimpanan stok di tingkat rak paling atas hendaklah mempunyai jarak 50 cm daripada siling bagi tujuan keselamatan.

6.1.3.3 Pelan Lokasi Stok perlu disediakan dan dikemaskini dari semasa ke semasa

6.1.3.4 Penyusunan barang dibuat berdasarkan 'First In First Out' (FIFO) atau 'First Expired First Out' (FEFO).

6.1.3.5 Stok ubat Dadah Merbahaya / Bahan Psikotropik diterima dan dikeluarkan ke unit pengguna (stor unit Farmasi Pesakit Dalam) untuk disimpan di almari ubat Dadah Merbahaya / Bahan Psikotropik.

#### 6.1.4 Pengeluaran

6.1.4.1 Ketua Jabatan perlu melantik Pegawai Pengeluar Stok dan Pegawai Pelulus Pengeluaran Stok

6.1.4.2 Semua pengeluaran stok perlu diluluskan oleh Pegawai Pelulus Pengeluaran Stok

6.1.4.3 Semua pesanan kepada Unit Farmasi Logistik perlu dibuat melalui PhIS. Bagi unit-unit yang tidak mempunyai PhIS, Borang Permohonan Stok (Antara Stor), Kew.PS-7 digunakan.

6.1.4.4 Pesanan stok oleh stor unit Farmasi pesakit dalam dan Farmasi pesakit luar akan dibuat setiap minggu antara hari Isnin hingga Rabu manakala pesanan stok oleh wad/unit dibuat setiap minggu pada hari isnin atau hari pertama setiap permulaan minggu.

6.1.4.5 Pesanan untuk kegunaan kecemasan boleh dibuat dengan syarat perlu berhubung dengan Pegawai Farmasi terlebih dahulu.

6.1.4.6 Setiap pengeluaran stok perlu direkod dalam Kad Daftar Stok Kew.PS-3.

|  | HOSPITAL SERIAN                |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

### 6.1.5 Pemeriksaan dan verifikasi stok

6.1.5.1 Pemeriksaan stok perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan stok tidak berlebihan, berkurangan, rosak, usang, luput dan sebagainya.

6.1.5.2 Untuk pemeriksaan stok, Ketua Jabatan perlu melantik pegawai-pegawai yang tidak terlibat dalam pengurusan stor untuk menjalankan pemeriksaan stok.

6.1.5.3 Untuk verifikasi stor, Pegawai pengawal, Ketua Pengarah atau Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) peringkat kementerian perlu melantik pegawai pemverifikasi yang tidak terlibat dalam pengurusan stor untuk menjalankan verifikasi stor.

### 6.1.6 Keselamatan

6.1.6.1 Buku Pelawat perlu diisi oleh staf bukan farmasi yang masuk untuk berurusan dengan staf farmasi di Unit Farmasi Logistik.

6.1.6.2 Staf farmasi yang masuk ke Unit Farmasi Logistik pada luar waktu pejabat untuk tujuan merekod suhu juga perlu mengisi Buku Pelawat.

6.1.6.3 Hanya staf farmasi sahaja dibenarkan masuk ke ruang penyimpanan stok di Farmasi Logistik

## 6.2 FARMASI PESAKIT LUAR

### 6.2.1 Pendispensan ubat kepada pesakit dari Unit Kecemasan & Trauma, pesakit temujanji dan pesakit discaj dari wad.

6.2.1.1 Hanya ubat yang ditulis dalam preskripsi yang sah dan oleh preskriber yang sah sahaja akan dibekalkan.

6.2.1.2 Tempoh sah laku preskripsi di hospital KKM adalah satu (1 tahun) bagi pesakit yang dikategorikan stabil dan memenuhi kelayakan demi mengawal kekerapan kehadiran pesakit ke fasiliti kesihatan KKM. Namun, bagi preskripsi yang mengandungi ubat DD dan psikotropik, tempoh sah laku adalah maksimum 90 hari mengikut Peraturan 11(3) Peraturan-peraturan Racun (Bahan-bahan Psikotropik) 1989.

|  | HOSPITAL SERIAN                |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N |                                                | Page    |     |          |     |

6.2.1.3 Bagi pembekalan ubat separa, preskripsi asal perlu diberikan kepada pesakit untuk pengambilan bekalan susulan.

6.2.1.4 Sekiranya pesakit menghilangkan atau terlupa membawa preskripsi asal semasa mendapatkan ubat, pesakit perlu berjumpa dengan Pegawai Perubatan untuk mendapatkan preskripsi baru.

6.2.1.5 Semua preskripsi yang dibekalkan ubat perlu direkodkan transaksinya dalam PHIS (sehingga tahap 'Dispense')

## 6.2.2 Perkhidmatan Selain Nilai Tambah Pendispensan (VAS)

6.2.2.1 Bekalan ubat selama 4 minggu (1 bulan) sahaja akan dibuat untuk semua preskripsi yang diterima. Pembekalan separa perlu dibuat setiap 4 minggu bagi preskripsi dengan tempoh bekalan ubat melebihi 4 minggu, sehingga tempoh preskripsi tamat.

6.2.2.2 Perkhidmatan Selain Nilai Tambah Pendispensan VAS perlu ditawarkan terlebih dahulu bagi pesakit yang mempunyai masalah mengambil ubat susulan.

- Jenis Perkhidmatan Selain Nilai Tambah Pendispensan VAS yang disediakan adalah:
  - SPUB (Sistem pendispensan ubat bersepadu) di klinik kesihatan kerajaan yang terdekat
  - Kad temujanji
  - MyUbat

6.2.2.3 Bekalan melebihi 4 minggu (maksimum 8 minggu / 2 bulan) hanya akan diberikan bagi pesakit yang mempunyai alasan munasabah dalam kesulitan mengambil ubat susulan.

6.2.2.4 Hanya preskripsi KKM dengan preskriber yang sah sahaja akan diterima (sama ada dengan rujukan SPUB atau Walk-In).

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

### 6.2.3 Perkhidmatan Kaunseling

6.2.3.1 Kaunseling ubat-ubatan dan pendidikan kepada pesakit adalah komponen utama penjagaan farmaseutikal yang perlu diberi penekanan oleh semua Pegawai Farmasi Ambulatori

6.2.3.2 Pesakit yang diberi kaunseling adalah yang mendapat rujukan daripada preskriber atau Pegawai Farmasi boleh mengenalpasti pesakit yang perlu diberi kaunseling.

6.2.3.3 Semua kaunseling yang dibuat hendaklah direkodkan dalam borang kaunseling (PHIS).

### 6.2.4 Pembekalan Ubat Psikotropik Terkawal/Dadah merbahaya

6.2.4.1 Penyimpanan stok hendaklah dalam kabinet/laci berkunci. Semua Pegawai Farmasi diberi kuasa untuk membuka kabinet/laci berkunci yang menyimpan stok ubat psikotropik di Unit Farmasi Pesakit Luar.

6.2.4.2 Pemeriksaan stok ubat psikotropik hendaklah dilakukan oleh Pegawai Farmasi secara bulanan.

6.2.4.3 Pesanan ubat psikotropik oleh staf Unit Farmasi Pesakit luar yang berada di lokasi "kaunter OPD" (PHIS) hendaklah membuat pesanan ke stor unit Farmasi Pesakit Dalam pada bila-bila masa atau sebaiknya memeriksa paras stok sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu.

6.2.4.4 Setiap transaksi hendaklah direkodkan dalam buku rekod Ubat Psikotropik Terkawal Unit Farmasi Pesakit Luar.

### 6.2.5 Pengurusan stok stor unit

6.2.5.1 Pemesanan stok dibuat oleh Penolong Pegawai Farmasi U6 setiap minggu melalui sistem PHIS. Pelulus pesanan ialah Pegawai Farmasi.

6.2.5.2 Stok yang diterima daripada Unit Farmasi Logistik direkodkan dalam kad daftar stok KEW.PS-3.



|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

## 6.3 FARMASI PESAKIT DALAM

### 6.3.1 Pembekalan Ubat Melalui Sistem (*Unit of Dose*)

6.3.1.1 Pembekalan ubat hanya dapat dilakukan sekiranya preskripsi UOD yang lengkap diterima oleh staff farmasi yang bertugas di Farmasi Pesakit Dalam.

6.3.1.2 Penghantaran troli dari wad lelaki, wad perempuan, wad kanak-kanak dan wad bersalin pada waktu pagi disertakan dengan senarai nama pesakit dan status samada pesakit baru / discaj/meninggal dunia/ pindah keluar

6.3.1.3 Semua preskripsi yang dibekalkan ubat perlu dibuat transaksi dalam PHIS (sehingga tahap *dispense*) pada hari yang sama preskripsi diterima.

### 6.3.2 Ubat sebagai stok simpanan di wad (*Floor Stock, After-Office-Hour Stock, dan Emergency Trolley*)

6.3.2.1 Pesanan ubat-ubatan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang pesanan yang disediakan oleh Unit Farmasi Pesakit Dalam.

6.3.2.2 Ubat *After-Office-Hour* (AOH) hanya dikhaskan untuk pembekalan kepada pesanan ubat baru untuk pesakit dalam wad selepas waktu bekerja sahaja.

6.3.2.3 Penetapan bagi penyediaan bekalan ubat internal dan eksternal hanya dibuat pada hari bekerja sahaja, tidak termasuk hari Sabtu, Ahad dan cuti umum.

6.3.2.4 Semua item harus dibekalkan dalam bekas yang sesuai dan dilabel Dengan jelas, termasuk ubat-ubatan yang perlu disimpan dalam kotak ais.

6.3.2.5 Semua ubat dalam bentuk ampul kaca perlu dibekal dalam bekas plastik atau bekas lain yang difikirkan sesuai untuk mengurangkan risiko pecah semasa penghantaran ke wad/ unit pemesan.

6.3.2.6 Pihak wad dikehendaki memastikan bungkusan ais (*ice pack*) dalam kotak ais adalah beku sepenuhnya semasa dihantar ke farmasi untuk mengutip ubat-ubatan yang memerlukan rangkaian sejuk.

6.3.2.7 Pihak wad dinasihati supaya tidak mengeluarkan ubat tablet daripada blister pack kecuali waktu pengambilan ubat oleh pesakit sahaja.

|  | HOSPITAL SERIAN                 |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                  | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

6.3.2.8 Pesanan bagi losyen dan disinfektan daripada wad/unit hanya diterima pada hari bekerja sahaja tidak termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum. Losyen dan disinfektan disediakan dan dikeluarkan oleh Farmasi Pesakit Dalam.

6.3.2.9 Semua transaksi pembekalan wad/unit hendaklah dimasukkan ke dalam Sistem PhIS.

### 6.3.3 Kaunseling ubat-ubatan Kepada Pesakit Dalam

6.3.3.1 Kaunseling ubat-ubatan dan pendidikan kepada pesakit adalah komponen utama penjagaan farmaseutikal yang perlu diberi penekanan oleh semua Pegawai Farmasi.

6.3.3.2 Pesakit yang diberi kaunseling adalah yang mendapat rujukan daripada preskriber atau Pegawai Farmasi boleh mengenalpasti pesakit yang memerlukan kaunseling.

6.3.3.3 Semua kaunseling yang dibuat hendaklah direkodkan dalam modul kaunseling (PHIS).

### 6.3.4 Pembekalan Ubat Psikotropik Terkawal/Dadah Merbahaya

6.3.4.1 Penyimpanan stok hendaklah dalam kabinet/almari berkunci.

6.3.4.2 Setiap pesanan hendaklah dibuat melalui borang (dua salinan) dan buku pesanan Ubat Psikotropik Terkawal setiap hari Selasa dan Khamis untuk wad/unit selain Farmasi.

6.3.4.3 Semua bekas ubat dan baki stok mesti dihantar ke farmasi semasa membuat pesanan.

6.3.4.4 Setiap bekalan hendaklah direkodkan dalam Buku Rekod Ubat Psikotropik Terkawal yang disimpan di setiap wad/unit dengan mencatatkan tarikh dibekal, nama dan kekuatan ubat, kuantiti, baki stok, nombor siri pesanan, nama dan tandatangan pegawai berkenaan.

|  | HOSPITAL SERIAN                |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE                 | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

### 6.3.5 Pemeriksaan Wad

6.3.5.1 Pemeriksaan wad akan dijalankan mengikut jadual yang disediakan mengikut giliran.

6.3.5.2 Pemeriksaan dijalankan mengikut borang pemeriksaan wad yang telah disediakan dan laporan akan dihantar kepada Ketua Wad/Unit untuk tindakan selanjutnya.

6.3.5.3 Wad/ Unit berkenaan hendak mengemukakan maklum balas tindakan pembetulan atau penambahbaikan dalam tempoh 2 minggu daripada memo maklum balas dari Unit Farmasi diterima.

### 6.3.6 Pengeluaran Farmaseutikal Dan Prabungkus

6.3.6.1 Proses penyediaan dan penyemakan sediaan farmaseutikal dan prabungkusan harus dijalankan oleh staf yang berlainan.

6.3.6.2 Penyediaan sediaan dan prabungkusan harus dijalankan mengikut Formulari galenikal yang terdapat dalam sistem PhIS.

6.3.6.3 Proses kerja harus mematuhi amalan Good Preparation Practice (GPP).

6.3.6.4 Kertas kerja harus disediakan dan disemak silang untuk setiap aktiviti penyediaan dan prabungkusan yang dijalankan.

6.3.6.5 Setiap sediaan farmaseutikal dan prabungkusan harus dilabel dengan lengkap.

### 6.3.7 Pengurusan stok stor unit

6.3.7.1 Pemesanan stok dibuat oleh Penolong Pegawai Farmasi U6 setiap minggu melalui sistem PHIS. Pelulus pesanan ialah Pegawai Farmasi.

6.3.7.2 Stok yang diterima daripada Unit Farmasi Logistik direkodkan dalam kad daftar stok KEW.PS-3.

## 6.4 FARMASI KLINIKAL

6.4.1 Aktiviti-aktiviti Farmasi Wad hendaklah merangkumi:

- Rondaan wad
- Penilaian sejarah pengubatan & rekonsiliasi (Borang CP1)

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

- Program Patient's Own Medicines (POM)
- Perancangan pelan penjagaan farmaseutikal (Borang CP2, CP3 & CP4)
- Pendispensan & kaunseling ubat (bedside & discaj)
- Perkhidmatan maklumat ubat & racun
- Aktiviti Antimicrobial Stewardship

#### **6.4.2 Aktiviti-aktiviti farmakokinetik klinikal**

6.4.2.1 Sampel darah perlu dihantar ke Hospital Umum Sarawak dan Hospital Sentosa bagi analisis Therapeutic Drug Monitoring (TDM).

6.4.2.2 Pegawai Farmasi wad bagi wad lelaki, wad perempuan dan wad kanak-kanak bertanggungjawab untuk melakukan interpretasi keputusan analisis TDM dan memaklumi doktor tentang keputusan analisis dan syor pengubahsuaian dos jika perlu.

6.4.2.3 Semua dokumentasi klinikal hendaklah dimasukkan ke dalam sistem PhIS

6.4.2.4 Sekiranya ada sampel darah perlu dihantar selepas waktu pejabat, pegawai perubatan hendaklah menghubungi Pegawai Farmasi yang bertugas atas panggilan untuk membuat semak silang borang sebelum dihantar.

### **7. POLISI PRESKRIPSI**

- 7.1 Setiap preskripsi hendaklah ditulis oleh pengamal perubatan atau pengamal pergigian berdaftar yang telah diberikan kebenaran oleh Pengarah Hospital untuk menjalankan amalan di Hospital Serian
- 7.2 Preskripsi mestilah ditulis dengan jelas dan bertarikh.
- 7.3 Preskripsi mestilah lengkap dengan nama pesakit, nombor kad pengenalan atau nombor pendaftaran (untuk pesakit wad), diagnosis, dan rejimen ubat (dos, kekerapan, cara pemberian, dan tempoh).
- 7.4 Nama ubat mestilah ditulis dalam nama generik, kecuali jika jenama tertentu diperlukan untuk keadaan spesifik.
- 7.5 Nama ubat hendaklah ditulis dengan jelas dan tidak boleh disingkatkan kecuali nama ubat yang dibenarkan oleh Pengarah ditulis secara

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

singkatan dan difahami.

**7.6** Preskripsi mestilah ditandatangani dan dicop oleh preskriber, serta menyatakan nama preskriber.

**7.7** Umur dan berat badan pesakit perlu dinyatakan, terutamanya bagi kanak-kanak di bawah 12 tahun.

**7.8** Prosedur jika preskripsi tidak lengkap:

**7.8.1** Usaha hendaklah dibuat untuk menghubungi preskriber bagi mengesahkan maksud.

**7.8.2** Jika berjaya, pegawai farmasi perlu memastikan butiran yang tidak lengkap diisi oleh preskriber.

**7.8.3** Jika tidak dapat memperoleh pindaan bertulis, pegawai farmasi boleh mengendors preskripsi sebagai '*Prescriber Contacted (PC)*' dengan tandatangan dan tarikh.

**7.8.4** Sekiranya preskriber tidak dapat dihubungi, preskripsi tidak lengkap bagi ubat bukan kritikal hendaklah dikembalikan kepada preskriber tersebut. Bagi ubat penyelamat nyawa pula, pegawai farmasi perlu mengambil langkah proaktif dengan menghubungi pakar atau pegawai perubatan lain yang berkaitan

**7.8.5** Pesanan ubat secara lisan melalui telefon tanpa penulisan preskripsi adalah dilarang dalam semua keadaan.

## **7.9 Kategori Pempreskrip yang Dibenarkan dalam Formulari Ubat KKM**

**7.9.1** Kategori preskriber yang boleh memulakan preskripsi:

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A*   | Pakar Perunding / Pakar bagi Indikasi yang Spesifik sahaja                                                               |
| A    | Pakar Perunding / Pakar                                                                                                  |
| A/KK | Pakar Perunding / Pakar / Pakar Perubatan Keluarga                                                                       |
| B    | Pakar Perunding / Pakar / Pakar Perubatan Keluarga / Pegawai Perubatan                                                   |
| C    | Pakar Perunding / Pakar / Pakar Perubatan Keluarga / Pegawai Perubatan / Anggota Paramedik                               |
| C+   | Pakar Perunding / Pakar / Pakar Perubatan Keluarga / Pegawai Perubatan / Anggota Paramedik/ Anggota Paramedik Perbidanan |

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

**7.9.2** Bagi bidang pergigian, Pakar Perunding Kanan/Pakar Perunding serta Pegawai Perubatan Pergigian adalah termasuk dalam kategori preskriber seperti di atas namun hanya bagi ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan pergigian.

**7.9.3** Preskripsi bagi ubat kategori A\*, A, dan A/KK hanya akan dibekalkan oleh pihak Farmasi untuk kes susulan atau selepas *Borang Pemonitoran Penggunaan Ubat-Ubatan Kategori A (PPUA)* dilengkapkan, susulan perundingan Pegawai Perubatan dengan pakar yang berkaitan secara lisan dan didokumentasikan dalam rekod kes pesakit.

## 8 PENGURUSAN FORMULARI UBAT-UBATAN

### 8.1 Pengurusan Formulari Ubat-ubatan KKM (FUKKM)

8.1.1 Pindaan FUKKM akan diedarkan oleh BPF JKN Sarawak dari semasa ke semasa.

8.1.2 Pegawai Maklumat Ubat (PMU) hendaklah mengedarkan salinan FUKKM terkini serta pindaan FUKKM kepada Pengarah, semua Pakar dan semua staf Farmasi melalui emel. Satu salinan juga hendaklah disimpan dalam fail atau secara maya di Jabatan Farmasi untuk rujukan semua staf Farmasi.

### 8.2 Pengurusan Formulari Ubat-ubatan Hospital Serian

8.2.1 Pegawai Farmasi di Sumber Maklumat Ubat (SMU) bertanggungjawab untuk mengemaskini Formulari Ubat-ubatan Hospital Serian 1 kali setahun (bagi Salinan *hardcopy*) dan setiap kali ada penyenaraian baru atau pemansuhan (dalam bentuk *softcopy*).

8.2.2 Kemaskini formulari hendaklah dibuat melalui Mesyuarat Jawatankuasa Ubat & Terapeutik (JKUT) Hospital Serian mengikut prosedur-prosedur berikut seperti yang diterangkan dalam Terma Rujukan (TOR) JKUT yang sedang berkuatkuasa.

8.2.3 Formulari Ubat-ubatan Hospital Serian yang dikemaskini dalam bentuk *hardcopy* hendaklah disahkan oleh Pengarah Hospital untuk simpanan dan rujukan di Jabatan Farmasi. Semua borang Dossier 4 harus difailkan bersama dengan salinan formulari yang dikemaskini.

8.2.4 Salinan formulari yang terkemaskini hendaklah diedarkan kepada Pengarah, semua Pakar dan semua staf Farmasi melalui emel. Satu salinan

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

juga hendaklah disimpan dalam fail di Jabatan Farmasi untuk rujukan semua staf Farmasi.

8.2.5 SMU hendaklah memaklumi JKUT dalam setiap mesyuarat mengenai bilangan ubat yang terkemaskini dalam Formulari Ubat-ubatan Hospital Serian.

### 8.3 Pengurusan Ubat Sampel

- Doktor pakar (pemohon) bertanggungjawab untuk menyimpan ubat sampel yang diluluskan di jabatan masing-masing.
- Semua penggunaan ubat sampel perlu mendapat kelulusan dari pengarah hospital.

#### 8.3.1 Penggunaan ubat PAPSA dan ubat-ubat sampel di luar Formulari Ubat-ubatan KKM (FUKKM)

- Doktor pakar yang berhasrat untuk menggunakan ubat PAPSA dan ubat sampel di luar FUKKM perlu mendapat kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) terlebih dahulu.
- Kelulusan khas KPK adalah untuk membenarkan penggunaan ubat sampel sahaja dan tidak terpakai terhadap pembelian ubat berkenaan apabila penajaan ubat sampel telah tamat.
- Dalam proses mengendalikan permohonan kelulusan KPK, pihak Farmasi harus mempertimbangkan implikasi kewangan yang akan ditanggung oleh pihak hospital apabila tawaran penajaan ubat sampel oleh syarikat farmaseutikal telah tamat.
- Doktor pakar (pemohon) dikehendaki untuk memastikan terdapat penyambungan perawatan kepada pesakit apabila ubat sampel yang digunakan tidak lagi ditaja.
- Doktor pakar (pemohon) perlu memaklumkan kepada pesakit bahawa ubat yang digunakan adalah untuk tempoh tertentu sahaja dan pihak hospital tidak terikat untuk menyambung perawatan pesakit dengan ubat yang sama apabila penajaan ubat sampel telah tamat.

|  | HOSPITAL SERIAN         |                        |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)      | Page    |     |          |     |

- f. Bagi permohonan menggunakan ubat sampel yang tidak berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD), pemohon perlu memastikan pesakit mengisi Borang Keizinan untuk Menjalani Rawatan dengan Ubat di Luar Indikasi sebelum memulakan perawatan.
- g. Doktor pakar (pemohon) perlu membuat permohonan baru bagi kelulusan khas KPK untuk memperolehi ubat berkenaan dengan menggunakan peruntukan KKM apabila penajaan ubat sampel telah tamat.
- h. Jika ubat sampel yang digunakan adalah untuk merawat penyakit bagi tempoh sepanjang hayat, pemohon dikehendaki untuk mengisi Borang Pemonitoran Penggunaan Ubat Kelulusan KPK dalam proses membuat permohonan untuk mendapat kelulusan khas KPK.
- i. Pesakit perlu menandatangani borang keizinan menggunakan ubat sampel sebelum bermula rawatan ubat sampel.

### 8.3.2 Penggunaan ubat PASc dan ubat-ubat sampel dalam Formulari Ubat-ubatan (FUKKM)

- a. Doktor pakar yang berhasrat untuk menggunakan ubat PASc dan ubat sampel di dalam FUKKM perlu mendapat kelulusan Pengarah Hospital.
- b. Kelulusan Pengarah Hospital adalah untuk membenarkan penggunaan ubat sampel sahaja dan tidak terpakai terhadap pembelian ubat berkenaan apabila penajaan ubat sampel telah tamat.
- c. Dalam proses mengendalikan permohonan kelulusan Pengarah Hospital, pihak Farmasi harus mempertimbangkan implikasi kewangan yang akan ditanggung oleh pihak hospital apabila tawaran penajaan ubat sampel oleh syarikat farmaseutikal telah tamat.
- d. Doktor pakar (pemohon) dikehendaki untuk memastikan terdapat penyambungan perawatan kepada pesakit apabila ubat sampel yang digunakan tidak lagi ditaja.
- e. Doktor pakar (pemohon) perlu memaklumkan kepada pesakit bahawa ubat sampel yang digunakan adalah untuk tempoh



|  | HOSPITAL SERIAN |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE  | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
| DOCUMENT IDENTIFICATION                                                           |                 |                                                | Page    |     |          |     |

tertentu sahaja dan pihak hospital tidak terikat untuk menyambung perawatan pesakit dengan ubat yang sama apabila penajaan ubat sampel telah tamat.

- f. Doktor pakar (pemohon) perlu membuat permohonan baru bagi kelulusan Pengarah Hospital untuk memperolehi ubat berkenaan dengan menggunakan peruntukan KKM apabila penajaan ubat sampel telah tamat.

#### 8.4 Penyimpanan Ubat Pembelian Sendiri oleh Pesakit

**8.4.1** Pihak Farmasi tidak akan menyimpan ubat-ubatan ini kecuali mendapat kelulusan daripada Pengarah Hospital. Ubat-ubatan ini biasanya memerlukan pengendalian atau keadaan penyimpanan khas yang tidak mampu diuruskan oleh pesakit.

**8.4.2** Surat keizinan untuk menyimpan ubat-ubatan ini perlu diperolehi daripada pesakit.

#### 8.5 Pengurusan Ubat-ubatan Kelulusan Khas (KPK/ PKPF & Kawalan khusus)

##### 8.5.1 Ubat-ubatan Kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK)/ Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF)

- a. Perolehan dan penggunaan ubat di luar Formulari Ubat-ubatan KKM (FUKKM) atau bagi indikasi di luar FUKKM hendaklah memohon kelulusan khas KPK/ PKPF terlebih dahulu mengikut Garis Panduan Permohonan Ubat Kelulusan Khas (UKK) Fasiliti - Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Edisi Kedua Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPF KKM.
- b. Bagi ubat tidak berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) dan tidak tersenarai dalam FUKKM atau ubat berdaftar tetapi digunakan untuk indikasi yang tidak berdaftar dengan PBKD (*off-label use*), Borang Keizinan untuk Menjalani Rawatan dengan Ubat/ Indikasi (*Off-label*) Tidak Berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (BPF/103-KPK03) hendaklah diisi.
- i. Pengecualian diberikan kepada ubat-ubatan yang dibenarkan penggunaan indikasi *off-label* dengan kelulusan KPK secara

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                   |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | <b>POLISI OPERASI<br/>FARMASI</b> | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION | <b>P&amp;P/18 (PHARMACY)</b>      | Page    |     |          |     |

pukul melalui memo BPF KKM terkini Ruj: KKM-55IBPF/1031001/17 bertarikh 29 Apr 2015.

- c. Semua permohonan kelulusan khas KPK/ PKPF hendaklah dihantar kepada KKM melalui penggunaan Submodul *Special Approval Medicines* dalam *Pharmacy Information System* (PhIS). Borang permohonan serta dokumen sokongan hendaklah dimuatnaik dalam PhIS bagi setiap permohonan yang dihantar.
- d. Permohonan kelulusan khas KPK/ PKPF di Hospital Serian hanya akan diproses berdasarkan ketersediaan peruntukan *dummy* yang ditetapkan oleh CFLN Sarawak kecuali adanya justifikasi bagi indikasi penyelamat nyawa atau rawatan kecemasan, pihak Farmasi bertanggungjawab untuk meminjam stok ubat daripada fasiliti lain atau menggunakan peruntukan hospital sedia ada atau memohon peruntukan tambahan daripada CFLN Sarawak.
- e. Permohonan ubat kelulusan KPK/PKPF yang terdapat alternatif dalam FUKKM (kecuali kes ADR atau gagal rawatan) perlu mendapat kelulusan dari JKUT Hospital Serian.
- f. Pegawai Farmasi SMU bertanggungjawab untuk memproses semua permohonan dan mengemaskini senarai ubat kelulusan khas KPK/ PKPF dari semasa ke semasa.
  - i. Pegawai Farmasi hendaklah menyediakan laporan *critical appraisal* bagi bukti-bukti *evidence-based* yang digunakan untuk menyokong permohonan KPK/ PKPF.
  - ii. Pegawai Farmasi hendaklah membentangkan laporan permohonan ubat KPK/ PKPF dalam setiap Mesyuarat JKUT.
  - iii. Pegawai Farmasi hendaklah membuat edaran emel kepada semua Ketua Jabatan mengenai senarai ubat KPK/ PKPF yang lambat bergerak atau bertarikh luput dari semasa ke semasa.
  - iv. Senarai Ubat-ubatan Kelulusan Khas KPK/ PKPF yang terkemaskini hendaklah diedarkan kepada semua staf Farmasi.

|                                                                                   |                         |                                   |         |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
|  | <b>HOSPITAL SERIAN</b>  |                                   |         |            |          |            |
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | <b>POLISI OPERASI<br/>FARMASI</b> | VERSION | <b>4.0</b> | REVISION | <b>0.0</b> |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION | <b>P&amp;P/18 (PHARMACY)</b>      | Page    |            |          |            |

### 8.5.2 Ubat-ubatan Kelulusan Khas Pengarah Hospital (Ubat Kawalan khusus)

- Perolehan dan penggunaan ubat di luar Formulari Ubat-ubatan Hospital Serian hendaklah memohon kelulusan khas Pengarah Hospital Serian. Penggunaan ubat yang mahal atau perlu dikawal memerlukan kelulusan Pengarah Hospital. Oleh itu, ubat tersebut dilabelkan sebagai Ubat Kawalan khusus.
- Penggunaan ubat kawalan khusus oleh jabatan yang tidak memperolehi kelulusan hanya dibenarkan atas persetujuan yang diberikan oleh jabatan yang mendapat kelulusan selepas kepentingan rawatan dipertimbangkan.
- Permohonan ubat kawalan khusus diproses berdasarkan ketersediaan peruntukan *dummy* bagi perolehan melalui sebutharga atau pembelian terus oleh CFLN Sarawak atau melalui Kontrak Pusat KKM.
- Permohonan ubat kawalan khusus sebagai ubat alternatif (kecuali kes ADR atau untuk meningkatkan komplan) hanya akan diproses dengan syarat pesakit adalah komplan kepada rawatan asal.

### 8.6 Pengurusan Ubat Bersumberkan Khinzir

- 8.6.1 Pengurusan ubat bersumberkan khinzir hendaklah berdasarkan Panduan Penggunaan Ubat-ubat yang Mengandungi Unsur Tidak Halal kepada Pesakit di KKM yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi KKM serta surat pindaan yang terkini.
- 8.6.2 SMU bertanggungjawab untuk mengemaskini Senarai Ubat Bersumberkan Khinzir sekurang-kurangnya sekali (1) setahun melalui pengesahan dalam Mesyuarat JKUT.
- 8.6.3 Borang Keizinan untuk Menjalani Rawatan dengan Ubat Bersumberkan Khinzir (Pesakit Muslim) hendaklah digunakan.
  - Borang keizinan yang lengkap diisi hendaklah difailkan dalam nota pesakit dan 1 salinan diberikan untuk pengetahuan pesakit atau penjaga.

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

## 9 PENDISPENSAN UBAT-UBATAN

### 9.1 Penyaringan preskripsi

9.1.1 Maklumat administratif preskripsi mesti disemak supaya ianya adalah lengkap (Nama & nombor kad pengenalan pesakit, tarikh preskripsi, diagnosis pesakit serta tandatangan & cop preskriber).

9.1.2 Maklumat ubat mesti disemak supaya ianya adalah lengkap (formulasi & cara pengambilan, nama ubat, regimen termasuk dos, frekuensi dan durasi serta arahan khas seperti tempat aplikasi ubat dan lain-lain).

9.1.3 Preskripsi yang melibatkan ubat Kategori A perlu disertakan dengan borang PPUA sekiranya ubat tersebut belum dipreskrib oleh pakar hospital kerajaan.

9.1.4 Preskripsi yang dipreskrib oleh penolong pegawai perubatan yang melibatkan ubat Kategori B harus dihantar kepada pegawai perubatan untuk tandatangan timbal.

9.1.5 Sebarang intervensi ke atas preskripsi harus dibincangkan dengan preskriber berkenaan dan dicatatkan di atas preskripsi berkenaan dan ditandatangani oleh staf yang melakukan intervensi.

### 9.2 Kemasukan data preskripsi (*transcribing of orders*) ke dalam Sistem *Pharmacy Information System (PhIS)*

9.2.1 Proses ini hanya boleh dilakukan oleh staf Farmasi yang memiliki kata laluan PhIS yang diluluskan oleh KPF dan telah menjalani latihan pengguna.

9.2.2 Langkah semak silang berasaskan preskripsi semasa kemasukan data preskripsi, pegisian ubat dan pendispensan ubat hendaklah diamalkan.

### 9.3 Pengisian preskripsi

9.3.1 Maklumat ubat mesti dibaca dengan lengkap termasuk nama, formulasi dan kekuatan sebelum memulakan pengisian ubat.

9.3.2 Perhatian mesti diberikan terhadap label ubat stok kaunter, khasnya ciri-ciri *Look-Alike & Sound-Alike* dan *High Alert Medication*.

|  | HOSPITAL SERIAN         |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE          | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT IDENTIFICATION |                                                | Page    |     |          |     |

9.3.3 Tarikh luput ubat mesti dipastikan supaya bekalan yang diberikan kepada pesakit boleh digunakan sehingga tarikh pengisian semula atau temujanji.

9.3.4 Label ubat PhIS mesti dilekatkan dengan kemas pada bungkusan ubat untuk memudahkan bacaan oleh pesakit.

9.3.5 Ubat mesti dibungkus dalam keadaan yang memudahkan semakan silang oleh pegawai lain.

9.3.6 Tarikh luput bagi sediaan extemporaneous dan galenikal yang dibungkus semula mesti ditulis pada label ubat untuk pengetahuan pesakit.

#### **9.4 Pendispensan ubat kepada pesakit**

9.4.1 Pendispensan ubat hanya boleh dilakukan oleh Pegawai Farmasi.

9.4.2 Identiti pesakit mesti disahkan melalui 2 pendekatan, iaitu menanyakan nama pesakit dan memohon pesakit/ penjaga untuk menunjukkan dokumen sokongan untuk membuktikan identiti pesakit.

9.4.3 Sejarah alahan pesakit kepada antibiotik mesti ditanya semasa pendispensan ubat kepada pesakit; manakala pertanyaan tentang sejarah alahan kepada ubat-ubat lain juga digalakkan semasa pendispensan.

9.4.4 Slip IOU (Nota hutang) akan diberikan apabila ubat tidak dapat dibekalkan dengan sepenuhnya.

### **10 PENGURUSAN MAKLUMAT UBAT DAN RACUN**

#### **10.1 Pengendalian Maklumat Ubat dan Racun**

10.1.1 Pegawai Farmasi bertanggungjawab kepada pertanyaan berkaitan dengan ubat dan racun.

10.1.2 Respon boleh diberi secara lisan atau bertulis dengan secepat mungkin atau dalam hari yang sama.

10.1.3 Semua pertanyaan maklumat ubat & racun hendaklah didokumenkan di dalam sistem PhIS.

|  | HOSPITAL SERIAN            |                           |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE             | POLISI OPERASI<br>FARMASI | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
|                                                                                   | DOCUMENT<br>IDENTIFICATION | P&P/18 (PHARMACY)         | Page    |     |          |     |

## 10.2 Pengendalian Alahan Ubat-ubatan

10.2.1 Pegawai Farmasi bertanggungjawab untuk menguruskan maklumat alahan ubat-ubatan pesakit mengikut Garis Panduan Pengurusan Maklumat Alahan Ubat Pesakit.

10.2.2 Sejarah alahan terhadap ubat hendaklah diperolehi dan dinilai semasa: kemasukan wad (oleh Pegawai Perubatan) dan pendispensan ubat (oleh Pegawai Farmasi).

10.2.3 Kad Alahan Ubat boleh dikeluarkan bagi kes alahan terhadap semua jenis ubat.

10.2.4 Semua kes alahan ubat hendaklah dinilai dan dilaporkan sebagai kesan advers ubat (ADR) jika berkaitan.

10.2.5 Pegawai Farmasi hendaklah menerangkan kegunaan Kad Alahan Ubat kepada pesakit atau penjaga dan memastikan penerimaan kad diperakui dalam Borang Permohonan dan Pembatalan Kad Alahan Ubat.

10.2.6 Sekiranya terdapat pembatalan status alahan ubat pesakit di atas sebab-sebab tertentu, ia perlu didokumentasi dengan jelas di semua rekod pesakit.

10.2.7 Pesakit perlu mengembalikan Kad Alahan Ubat kepada Pegawai Farmasi sekiranya terdapat pembatalan status alahan ubat yang telah disahkan oleh Pegawai Perubatan dan Borang Permohonan dan Pembatalan Kad Alahan Ubat diserahkan ke Jabatan Farmasi.

## 10.3 pengendalian *Adverse Drug Reaction (ADR) & Adverse Event Following Immunisation (AEFI)*

10.3.1 Semua kategori staf boleh membuat laporan ADR & AEFI.

10.3.2 Semua data dan laporan ADR & AEFI yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Sistem PhIS yang telah berintegrasi dengan Sistem QUEST 3+ di Agensi Regulatori Farmasi Negara (NPRA).

|  | HOSPITAL SERIAN |                                                |         |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----|
|                                                                                   | DOCUMENT TITLE  | POLISI OPERASI<br>FARMASI<br>P&P/18 (PHARMACY) | VERSION | 4.0 | REVISION | 0.0 |
| DOCUMENT<br>IDENTIFICATIO<br>N                                                    |                 |                                                | Page    |     |          |     |

10.3.3 Laporan ADR & AEFI hendaklah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Pengubatan.

#### 10.4 Pengendalian kesilapan pengubatan (*Medication Errors, ME*)

10.4.1 **Actual ME** merujuk kepada kesilapan pengubatan yang telah sampai kepada pesakit tanpa mengira sama ada pesakit telah menggunakan atau makan ubat yang salah atau telah diadministrasi dengan ubat yang salah.

10.4.2 **Near-miss ME** merujuk kepada kesilapan pengubatan yang belum sampai kepada pesakit di mana kesilapan berkenaan telah dikesan oleh staf Farmasi atau staf lain di wad atau unit sebelum ubat yang salah diberikan kepada pesakit.

10.4.3 Semua kategori staf di hospital boleh membuat laporan ME.

10.4.4 Semua laporan ME yang lengkap diisi oleh pihak wad atau unit hendaklah dihantar ke Unit Farmasi untuk tindakan lanjut.

10.4.5 Pegawai farmasi yang melaporkan ME dalam MERS Online hendaklah memastikan maklumat mengenai langkah penambahbaikan atau pencegahan diisikan secara ringkas. Pengisian maklumat ini boleh berasaskan cadangan peribadi staf berkenaan atau, jika masa mengizinkan, boleh dirujuk kepada hasil RCA (*root-cause analysis*) yang kemudian disediakan oleh Pasukan RCA bagi kes IR tersebut.

10.4.6 RCA perlu dijalankan ke atas ME mengikut garis panduan pelaporan KKM dan mengikut arahan daripada Unit Kualiti.

10.4.7 Laporan ME hendaklah difailkan dan disimpan oleh unit Farmasi

10.4.8 Unit Farmasi hendaklah menyediakan laporan ME untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Pengubatan.

